



- לרוב התפיסה שהאם אינה מייצרת מספיק חלב עבור תינוקה, הינה תפיסה מוטעית.
- חוסר ידע לגבי דפוסי הנקה נורמאליים וציפיות לא מציאותיות הם גורמים מרכזיים בתלונה של מחסור בחלב.
- יחסי הגומלין בין תצרוכת החלב של התינוק ואספקת החלב של האם הינם מורכבים, וישנם גורמים רבים המשפיעים.
- מהירות וכמות הפרשת החלב שונה מאישה לאישה.

תצרוכת חלב נמוכה



למה יש לשים לב לפני הלידה?

- מרווח בין השדיים, היפופלסיה, חוסר התפתחות של השד.
- ניסיון עבר של מיעוט חלב או חוסר עליה במשקל של תינוק.
- ניתוחי שד
- מבנה הפטמה ויכולת ההזדקרות שלה.
- קשיים בכניסה להריון.



- חשוב להעריך סיכונים על מנת לזהות נשים עם פוטנציאל למיעוט חלב.
- כדאי להעריך את המצב עוד בזמן ההריון, כדאי לאפשר מעקב אחרי אותן נשים מיד עם הלידה.
- עיכוב בייצור החלב מחייב זיהוי מוקדם כדי לא לבזבז זמן יקר ולקיים התערבות כמה שיותר מהר.



- לכל מאורע, התנהגות, התנהלות או מנהג שמרחיקים את התינוק מהשד או משאירים חלב בשד לזמן ארוך (למעלה מ-4 שעות) יש פוטנציאל להפחית את כמויות החלב.
- גורמים כאלו כוללים:
- האכלה לפי השעון
- שימוש בבקבוקים ללא שאיבה במקביל
- שימוש במוצצים
- מחלה של האם או התינוק.



LACTOGENESIS 1

- היכולת של רקמת השד להפריש חלב מאמצע ההיריון עד לסופו.
- שלב זה מאופיין בגדילת השד, כשתאי האפיתל של האלוואולי מתמיינים לתאים מפרישים לייצור חלב.
- עליה ברקמת השומן ובכמות הלקטוז הנמצאת בשד, החלב מתחיל להצטבר בצינוריות החלב
- שלב זה מתקיים ללא קשר לתחילת ההנקה.



- ריקון השד על ידי התינוק או משאבה מעוררים את המשך יצירת החלב.
- אספקת החלב מונעת על ידי התינוק.
- במצב אנומלי, אספקת החלב לא מומרצת כראוי, כיוון שהתינוק אינו יונק בתדירות גבוהה, אינו יעיל בריקון החלב, או (לעיתים נדירות) פיזיולוגית האם אינה מסוגלת להגיב לגירוי יניקת התינוק.



LACTOGENESIS 2

- ההתחלה של הפרשת החלב השופעת אחרי הלידה.
- בזמן זה נפח החלב עולה במהירות ב- 36-96 שעות הראשונות מהלידה, ואז פתאום מתייבב.
- קצב ייצור החלב עולה מאוד ומושך מים לתוך מה שהיה קולוסטרום והופך אותו לחלב מעבר.
- נשים מרגישות את השלב הזה 50-60 שעות אחרי הלידה כאשר התהליך כבר בשיאו והשדיים מתמלאים חלב.
- הוא מופעל כתוצאה מהירידה הפתאומית בסרום הפרוגסטרוגן (ויכול להיות גם של אסטרוגן) לאחר יציאת השלייה



- עליה ברמת הורמון הפרולקטין מתרחשת במהלך תקופת ההריון החל משבוע 16-20
- עקב עליית רמת פרולקטין בהריון, השד מתחיל לייצר חלב, אך רמתו הגבוהה של הפרוגסטרוגן המופרש ע"י השליה מונעת את הפרשת החלב
- עם הלידה והוצאת השליה קיימת ירידה פתאומית ברמות פרוגסטרוגן / אסטרוגן / HPL.
- נסיגה פתאומית של פרוגסטרוגן בנוכחות גבוהה של פרולקטין יוצרת את השלב הבא (ייצור חלב בשפע).



הורמונים ומערכת ייצור החלב

- חשוב שיתקיים איזון במערכת ההורמונאלית.
- גירוי אפקטיבי ייצר כמות טובה של רצפטורים.



השינויים ההורמונליים הבאים הכרחיים להתחלת הנקה

- ירידה ברמות הפרוגסטרוגן
- כתוצאה מהפרשת הפרולקטין מהחלק הקדמי של ההיפופיזה ישנו גירוי ללקטוג'נסיס ולהתחלת הפרשת החלב.
- הוצאת החלב ע"י התינוק/ משאבה = כתוצאה מאוקסיטוצין שמופרש מהחלק האחורי של ההיפופיזה (לפחות ביום ה- 3).



מהו עיכוב בלקטוגיניזם?2

- מרווח זמן ארוך מהמצופה בין שלב הקולוסטרם וייצור שפע חלב .
- מתי נקבע שיש עיכוב ?
- תחושה של האם שאין טפטוף .אולו מלאות בשד 72 שעות לאחר הלידה .



המשוואה

- מספיק רקמת שד +
- מספיק מוליכים עצביים ותעלות חלב +
- איזון הורמונלי +
- רצפטורים בכמות מספקת +
- הנקה על פי דרישה +
- ניקוח טוב של החלב מהשד

כמות חלב טובה



לקטוגיניזם 2 מאוחר, הנמדד על ידי תחושת האם

- נמצא קשור לניתוח קיסרי
- לידה מוקדמת.
- סכרת התלויה באינסולין.
- השמנת יתר.
- הפרעות אנדוקריניות
- משככי כאבים בלידה.
- שחלות פוליציסטיות.
- שאריות שלייה ברחם.
- סטרס-רמות לחץ גבוהות לאם ולתינוק בזמן הלידה



מחלקים לקטוגיניזם כושל לכמה קטגוריות:

- טרום ייצור- עקב שאריות שליה ברחם או חסר בפרולקטין.
- ייצור- עקב פרוצדורה ניתוחית או חסר ברקמת שד.
- פוסט ייצור- עקב ריקון לא מספק של השד.



- לרוב האמהות יש יכולת ייצור חלב של שליש יותר מאשר הכמות שהתינוק זקוק.
- למרות זאת, אם השדיים לא מרוקנים מ-75-85% מהכמות שבהם, במרבית הזמן על ידי התינוק או באמצעות המשאבה, קצב ייצור החלב יורד בהתאמה לביקוש הנמוך.
- אם התינוק לא מצליח להוציא מספיק חלב, ייצור החלב יפחת במהרה אלא אם כן האם שואבת או סוחטת.



- הנקה יעילה, מוקדמת ותכופה היא כנראה הגורם החשוב ביותר בביסוס הנקה מוצלחת.
- פרצי פרולקטין קשורים למציות התינוק או לשאיבה תומכים בגדילה מתמשכת של רקמה מפרישה (secretory) במשך שבועות או חודשים לאחר הלידה
- ישנן מעט נשים שאינן מסוגלות לייצר מספיק חלב עבור תינוק אחד



צריכת חלב ושעור עליה במשקל

- במהלך תקופת הנקה בלעדית תינוקות צורכים בין 600-900 מ"ל חלב אם ביום.
- תינוקות גדולים צורכים כמויות גדולות יותר מתינוקות קטנים .
- תינוקות הניזונים מתמ"ל צורכים כמויות גדולות יותר של תמ"ל מאשר כמות חלב האם שתינוק יונק צורך.
- יחד עם זאת, הפעילות והגדילה דומות בשלושת החודשים הראשונים.



גודל השד

- לגודל השד יש תפקיד משמעותי בניהול ההנקה .
- אישה בעלת שדיים קטנים, יתכן ותצטרך להניק לעיתים קרובות יותר, כי פחות חלב יכול להאגר בשד בזמן נתון.



- קצב גידלה של תינוק נמדד באמצעות 3 פרמטרים
- משקל
- גובה
- היקף ראש



- רוב הילדים יורדים במשקל בימים הראשונים לאחר הלידה. אובדן משקל של יותר מ- 7% ממשקל הלידה יכול להוות סממן לבעיות
- תינוק בריא שנולד במועד יחזור למשקל לידה לא יאוחר מיום 14 לחייו.
- לאחר מכן יעלה 113 עד 219 ג' בשבוע (כ-450 ג') בחודש.
- תוספת המשקל הממוצעת הנה 34 ג'/יום לבנות ו-40 ג'/יום לבנים במהלך שלושת החודשים הראשונים.
- עבור שני המינים, תוספת המשקל המינימלית המקובלת הנה 20 ג'/יום במשך שלושת החודשים הראשונים. (-150 170גם בשבוע)



תינוקות שנולדו קרוב למועד

- לרוב מתייחסים לתינוקות שנולדים בין השבועות 35-37 כתינוקות רגילים לכל דבר.
- לרוב הם נולדים במשקל מעל 2500 גרם.
- אין להם סיבוכים רפואיים.
- שוהים בבית מלא עם אמם
- משתחררים מוקדם מביה"ח.
- למרות זאת מחקרים מראים שתינוקות אלו נמצאים בסיכון של פי 5 עד 10 לחזרה לביה"ח בגלל בעיות הזנה, וכתוצאה מכך איבוד משקל ו/או צהבת ילודים.



- תצרוכת נמוכה גורמת לצריכה קלורית נמוכה שמובילה לחוסר עליה במשקל.
- בשלב הבא משפיע על האורך.
- היקף הראש היא המדידה האחרונה שמושפעת מבעיות תזונה. אם קיים פיגור באורך לפני המשקל, יש חשש שמדובר במחלה.



- קשה להסיק מסקנות ממחקרים שנעשו על תינוקות כיוון שכל מחקר מתוכנן באופן שונה, מייצג אוכלוסיות שונות והוא בעל הגדרה שונה של "עליה לא מספקת במשקל". בדיקה של הנמשא מהצד האימהי בעייתית לא פחות, כיוון שאין הגדרה אחידה של "יצירה מועטת של חלב", ומתעורבים גורמים ביולוגיים, תרבותיים ופסיכולוגיים.



תצרוכת ואספקה נמוכות - הגדרות ומידת ההתרחשות

- טרמינולוגיה בנוגע לגדילה לא נורמלית יכולה להיות מבלבלת ולטקסטים שונים יש הגדרות שונות ל-FTT (Failure to thrive) חלקן בעלות קונוטציה מאוד שלילית ורומזות על הורות לקויה והתעללות בילד.
- המונח **היעדר שגשוג** מתייחס לאי הגעה למשקל יעד תואם גיל אצל תינוקות וילדים צעירים. היעדר שגשוג עשוי להתבטא בתת משקל, גובה שאינו תואם את גיל הילד, האטה בהתפתחות מוטורית וכללית ופנים חסרות הבעה.



סימנים מרגיעים:	הרציונל:
התינוק ערני, מבקש לאכול ונראה מרוצה לאחר האוכל	תינוק ערני רומז לאם לציין שהוא רעב ואח"כ שהוא מרוצה
תינוק יונק בצורה פעילה לפחות 160-180 דקות ביום בשבועיים הראשונים	נדרשת לפחות כמות זמן כזו על מנת לקבל מספיק חלב
נשמע קול בליעה	בליעה משקפת צריכת חלב
לאחר האכלה פטמת האם רטובה, שלמה ונוחה	כאב, סדקים או נזק מצביעים על מעבר חלב לא תקין
אם ותינוק מרוצים מהאכלה	האם מדווחות בעיות בהאכלה בצורה מדויקת
הקרומים היריריים של התינוק רטובים. עור שנצבט בעדינות לא נשאר גבוה מעל המשטח הנורמלי	סימנים שמצביעים על כך שהתינוק מקבל מספיק נוזלים ואינו מיובש
החל מהיום הרביעי או החמישי יש לתינוק 4-5 יציאות רכות צהובות עד סוף השבוע הראשון, יש לתינוק 6 טיטולים רטובים ביום. השתן צלול (לא כהה או מרוכז)	יציאות בשפע לעיתים קרובות הן הסימן הטוב ביותר לצריכת חלב מספקת שתן בשפע הוא סמן לתצרוכת נוזלים מספקת לאחר מספר ימים ראשונים.



- התינוק חייב לקבל מספיק חלב על מנת לגדול ולשגשג. כשיש העברת חלב לעיתים קרובות ובכמות מספקת, ישנם סימנים שמרגיעים את ההורים ואנשי המקצוע שהכל מתקדם כראוי.



סימנים שמראים שהתהליך נורמאלי אצל האימא

- רגישות בשדיים בטרימסטר הראשון
- השד גדל
- שינוי בצבע העטרה
- הורידים יותר ברורים
- השד מלא, חם ודחוס ביום השלשי אחרי הלידה
- התכווצויות של הרחם בזמן הנקה
- השד מרגיש נוקז אחרי האכלה



סימנים לצריכת חלב מספקת

יום	צריכת חלב	יציאות
1	5-100 מ"ג (קולוסטרום)	חיתול אחד רטוב, אחד יציאה שחורה (ופת)
2	10-120 מ"ג (קולוסטרום)	2 רטובים
3	200 מ"ג	3 רטובים, יציאות ירוקות
4	400 מ"ג	4 רטובים, 4 יציאות צהובות רכות
5	600+ מ"ג	6 רטובים 3-4 יציאות צהובות
6 ימים עד 6 חודשים	550-950 מ"ג	6 רטובים, 3-5 יציאות רכות צהובות



אם התינוק לא מוציא מספיק חלב מהשד הוא יפגין סימני רעב:

- התינוק נראה לא רגוע, עצבני
- מתנהג כ"רעב כל הזמן", במיוחד מיד אחרי האוכל.
- מוצץ את האגרופים או השמכה.
- מזיז את הראש מצד לצד במהירות על השד.
- מתנתק לעיתים תכופות מהפטמה.
- בוכה או מילל לעיתים קרובות.
- קשה להרגיע אותו או שהוא עצבני מיד אחרי הנקה.
- האכלות ארוכות (יותר מ-30 דקות) או קצרות (פחות מ-5 דקות) מאוד.
- לוקח בהתלהבות תמ"ל או חלב שאוב מיד לאחר האכלה.
- נרדם על השד אבל לא משחרר את השד.



לצורך הדיון ההגדרה של יציאה לא מספקת של חלב היא:

- כמות חלב שאינה גורמת לעליית משקל תקינה אצל התינוק, למרות ניהול תקין של ההנקות, מוטיבציה גבוהה של האם להניק ועזרה מקצועית בפתרון בעיות הנקה



קפיצות גדילה

- קפיצת גדילה היא תקופה בה היונק יונק בתדירות גבוהה יותר במטרה לאותת לגוף האם לייצר יותר חלב, זאת על מנת להתאים את כמות החלב לצרכיו הגדלים של היונק.
- קפיצות גדילה אופייניות נמשכות בדרך כלל בין **24-48 שעות**, אך הן משתנות מתינוק לתינוק. יש אחדים שקפיצת הגדילה שלהם תבוא לידי ביטוי רק בלילה, ואחרים לא יסכימו לרדת מהשד במשך 24 שעות רצופות.
- קפיצות הגדילה הסטנדרטיות מתרחשות בדרך כלל בגילאים: **7 ימים, 10-14 ימים, 3 שבועות, 6 שבועות, 3 חודשים ו-6 חודשים**.
- יש אמהות שלא מרגישות בקפיצות הגדילה כלל, ויש המרגישות בהן במועדים אחרים משוין.



פרוש לא נכון של סימנים

- האכלות צפופות - הנקות צפופות בייחוד בשבועות הראשונים הם נורמאליים.
- בימים הראשונים התינוק ינק בתדירות גבוהה (בייחוד ביום השני) אפילו כל חצי שעה . אחרי שהחלב מגיע רוב התינוקות ינקו בתדירות של כל שעתיים 8-12 פעמים ביום .
- האכלות צבר CLUSTER FEEDS - האכלות צפופות



התינוק יונק במשך פחות זמן מבעבר

- כשתינוקות גדלים ונהיים מיומנים יותר ביניקה ובהוצאת החלב, הם פשוט זקוקים לפחות זמן בכל יניקה.



התינוק יונק לעיתים קרובות.

- חלב אם מתעכל במהירות (בדרך כלל תוך 2-1.5 שעות), ולכן תינוקות יונקים צריכים לאכול לעיתים קרובות יותר מאשר תינוקות הניזונים מתחליף חלב. בנוסף, לתינוקות רבים יש צורך עז למצוץ, או שהם זקוקים לקשר פיזי רציף עם אמה כדי להרגיש בטוחים.
- כל הדברים האלה הם נורמאליים, אין זה "פינוק יתר" לאפשר לתינוק להיות על השד בתדירות גבוהה.



תינוק בוכה ולוקח בקבוק אחרי האכלה

- יש תינוקות שייקחו בקבוק חלב מיד לאחר סיום האכלה אל אף ולמרות שקיבלו כמות טובה של חלב מהשד.
- יש מצבים שהתינוק בסה"כ זקוק לעוד מציצה.



תינוק עצבני

- לתינוקות רבים יש שעות מסוימות ביום שהם עצבניים יותר - לעיתים קרובות זה קורה בשעות הערב.
- חלק מהתינוקות עצבניים במשך שעות רבות במהלך היום.
- עצבנות כזו יכולה לנבוע מאינספור מסיבות, וברוב המקרים היא עוברת מעצמה מבלי שגילית מה הייתה הסיבה.



החלב הפסיק לדלוף מהשדיים או שישנה דליפה מעטה.

- לדליפת חלב אין שום קשר לאספקת החלב שלך. לעיתים קרובות הדליפה מפסיקה לאחר שאספקת החלב שלך מותאמת לצרכים של התינוק.



התינוק לא ישן במהלך הלילה

- זה מגיעה בגלל תפיסת עולם מוטעית שתינוק צריכים לישון במהלך הלילה.

את לא מרגישה את רגע כניסת החלב, או שההרגשה פחותה מבעבר

- חלק מהנשים מעולם לא מרגישות את כניסת החלב. זה לא קשור לאספקת החלב.

השדיים שלך פתאום נראים רכים

- זה בדרך כלל קורה אחרי שאספקת החלב מותאמת לצרכים של התינוק.

סיבות אפשריות לאספקת חלב נמוכה

- **בלבול פטמות.** באכילה מבקבוק, טכניקת המציצה של התינוק שונה מאוד מזו שמתרחשת בהנקה. באופן כללי, אכילה מבקבוק קלה לתינוק הרבה יותר מיניקה, שכן הוא צריך להפעיל מעט מאוד כוח יניקה, אם בכלל, כדי לחלץ את החלב מהבקבוק. כתוצאה מכך, מתן בקבוק, אפילו מידי פעם, יכול לגרום לתינוק לא למצוץ כמו שצריך כאשר הוא על השד. התינוק אף עלול להעדיף את הזרימה המהירה מהבקבוק על פני היניקה, ולהתנגד לניסיונות להניק אותו. במקרים אלו, אספקת החלב עלולה לרדת עקב הירידה בכמות אותה יונק התינוק מהשד.

בשימוש במשאבת חלב, אינך מצליחה לשאוב הרבה או בכלל לא.

- כמות החלב שניתן לשאוב היא לא מדד מדויק של אספקת החלב שלך. תינוק בריא יונק חלב מהשד שלך ביעילות רבה יותר מאשר כל משאבה! כמו כן, שאיבה היא מיומנות נרכשת, והיא יכולה להיות תלויה מאוד בסוג המשאבה. יש נשים שיש להן אספקת חלב בשפע אך הן אינן מסוגלות להוציא חלב בשאיבה..



מתן תוספות

- הנקה היא תהליך של "ביקוש והיצע". החלב מיוצר בכמות התואמת לזו שהתינוק יונק מהשד. כל בקבוק שניתן לתינוק (מיץ, תחליף חלב או מים) יעביר לגוף שלך את המסר שהתינוק שלך זקוק לפחות חלב אם, והתפוקה תרד בהתאם.



מוצצים

- מוצצים יכולים גם הם לגרום לבלבול פטמות. הם עשויים גם להפחית באופן משמעותי את משך הזמן שהתינוק מבלה על השד, דבר שעלול לגרום לאספקת החלב שלך להתמעט.



האכלה לפי לוח זמנים קבוע

- עלולה להפריע למחזור הביקוש וההיצע הטבעיים של ייצור החלב. לעיתים, הירידה באספקת החלב מתרחשת רק כמה חודשים לאחר תחילת משטר ההנקות המסודר. הפתרון פשוט: הניקי את התינוק שלך בכל פעם שהוא רעב, ותני לגוף לעשות את שלו



מגני פטמות

- יכולים לגרום הן לבלבול פטמות, הן להפחתת גירוי הפטמה שלך, והן להפרעה לזרימת החלב מהפטמה לתינוק - שלושתם מצבים אשר יכולים להפריע למחזור האספקה לפי דרישה.



קיצור משך ההנקה

- הפסקת ההנקה לפני שהתינוק מסיים ומתנתק בעצמו, יכולה להפריע למחזור האספקה לפי דרישה.



תינוק ישנוני.

- במשך השבועות הראשונים לחייהם, תינוקות מסוימים נוטים להיות מנומנמים מאוד, ודורשים לינוק לעתים רחוקות ולפרקי זמן קצרים. עד שהתינוק יתחיל להתעורר לבדו ולדרוש הנקה באופן קבוע, יש להניק אותו לפחות כל שעתיים במשך היום ולפחות כל שלוש שעות בלילה, על מנת לבנות את אספקת החלב שלך.



בעיות בריאותיות או אנטומיות של התינוק

- יכולות למנוע את ממנו להוציא חלב בכמות מספקת מהשד, וכך להקטין את אספקת החלב.



הצעת צד אחד בלבד בכל הנקה.

- אם אספקת החלב שלך מבוססת והתינוק שלך עולה במשקל היטב, אין בעיה מיוחדת בהנקה מצד אחד בלבד בכל פעם. אולם אם את מנסה להגדיל את אספקת החלב שלך, כדאי לתת לתינוק לסיים את הצד הראשון ואז להציע את הצד השני.



- לרוב להפרעה זו נלוות תופעות כגון פטמות פצועות וכואבות ועליה מעטה במשקל אצל התינוק.
- תינוקות אלו יישארו רגועים ורדומים רק על השד. למרות שהם נראים רגועים, כאשר יזזו אותם מהשד, יבכו מרעב.
- היניקות ה- nutritive יהיו מעטות ורק בהתחלה, ומהר מאוד יעברו ליניקות nonnutritive.
- במצבים כאלו קשה מאוד לקבוע אם הבעיה ההתחלתית הייתה אצל האם או התינוק.



הפרעה אוראלית - מוטורית (יניקה לא אפקטיבית)

- כאשר תינוקות יונקים נמצאים על השד הרבה ועדיין מתקשים להוציא חלב, קיימות שתי בעיות אפשריות (ביחד או בנפרד). או שהחיבור לא טוב, או שקיימת איזושהי חריגות ביניקה.
- הפרעה אוראלית - מוטורית יכולה להופיע בצורה עדינה אצל תינוקות "נורמאליים", לרוב בשילוב בעיה מוטורית. תינוקות אלו יכולים לרכוש מיומנות בלפחות שיטת האכלה אחת: בקבוק, כוס או אצבע. הפרעות אלו יהפכו למדאיגות במיוחד כאשר קיים סיבוך רפואי נוסף כגון בעיה נירולוגית או שפה/חיך שסועים.



בעיות נירולוגיות לא ספציפיות

- בעיות אלו קשות לאבחון מוקדם, אך לרוב פוגעות בהתפתחות. הסמנים של רפלקס, האכלה לא מאורגנת או חנק, חוסר יכולת זמנית וקצרה לנשום, או קצב איטי של suck-swallow-breathe.
- תופעות אלו קורות בכל דרכי ההאכלות: שד, בקבוק, כוס, אצבע.



ריפלוקס/ אלרגיה לחלב פרה/ אספקת יתר

- מחקר עכשווי קובע שכמחצית מהתינוקות עד גיל שנה שסובלים מריפלוקס (GER), יש להם איזושהי אלרגיה לחלב פרה.
- למרות שתופעה זו שכיחה הרבה יותר בקרב תינוקות הניזונים מתמ"ל, קיימים מקרים של תינוקות יונקים שסובלים מבעיות אלו.
- וריאציה אחת של ריפלוקס אצל תינוקות יונקים נובעת מאספקת יתר של חלב אם.



תינוק עם מחלה ברורה

- נוכחותה של מחלה ברורה (מופיע ברשימת גורמי הסיכון), מעמידה את התינוק בסיכון להתפתחות לקויה. לרוב אצל תינוקות אלו קיים שילוב של דרישות מטבוליות מוגברות, קושי לאכול ושעורי גדילה נמוכים, למרות ההקפדה בשמירה על שגרת האכלות.



ANKYLOGLOSSIA (פרנולום מתוח, לשון קשורה)

- פרנולום מתוח יכול לגרום לבעיות הנקה כגון צריכה מעטה של חלב, אספקה לא מספקת או פטמות פגועות.



- סינדרום אי-ספיגת המעיין
- הפרעה אורלי-מוטורית (מציצה לא תקינה)
- לידה לפני הזמן (פגות)
- מחלת כליות
- זיהום בילוד
- בעיות תפקוד של בלוטת התריס
- דלקת בדרכי השתן
- פגיעה באיבר או במערכת הגוף על-ידי המערכת החיסונית של אותו גוף.



- אלרגיה
- מחלה אוטו-אימונית
- בעיות כיס המרה
- שפה או חך שסועים
- פגם במערכת העצבים המרכזית
- מחלות לב מולדות
- סיסטיק פיבריס
- דלקות גסטרואנטרולוגיות
- פגמים גסטרואנטרולוגיים
- ריפלוקס
- היפוקלצמיה (תת סידן בדם)
- בעיות מולדות בחילוף החומרים



פטמות הפוכות

- כיוון שפטמות הפוכות עלולות לגרום לבעיה בחיבור, כתוצאה מכך אספקת החלב יכולה להיות מושפעת. מומחים רבים ממליצים כבר בטרימסטר השלישי להריון לעבור בדיקת שדיים על מנת "לטפל" בפטמות הפוכות, למרות שאין הוכחה לכך שהדבר יעזור.



גורמי האם: אמא שנראית בריאה

• סטרס

לידה היא אירוע מלחיץ, ובנוסף נשים רבות חוות מתח פיזי, רגשי וחברתי לאחר הלידה עם השינויים הרבים שחלים על המשפחה. לחץ זה צפוי ולא אמור להשפיע על ההנקה. נמצא כי סטרס מתון עד חמור מדכאים שחרור אוקסיטוצין וכתוצאה מכך משפיעים על יצירת החלב.



עישון

- מחקרים רבים מראים את הנזק הרב שעישון האם גורם לכל תהליך ההנקה: יצירת החלב, הכמות, עלייה במשקל של התינוק ומשך ההנקה.
- בהתייחסות לעישון פסיבי, והוסק שהוא מקצר את תהליך ההנקה.
- נזקי העישון הם רבים מאד, וכוללים גם ייצור מופחת של חלב, עצבנות של התינוק, קצב עלייה איטי במשקל, הגברת הסיכון למוות בעריסה וגם חשיפה גדולה למזהמים באוויר, שעלולה להגביר את הסיכון למחלות נשימה שונות.



תרופות וחומרים

- במקרים נדירות תרופות שהאם לוקחת יפגעו בחלב. למרות שהרגישות משתנה מאדם לאדם, לרוב גלולות למניעת הריון מפחיתות את יצירת החלב.
- תרופות משתנות במינויים גבוהים או למשך תקופה ארוכה עלולות לדכא את ההנקה.



הפרעות הורמונאליות

- תהליך יצירת החלב תלוי בתפקוד תקין של הורמונים. לכן, לא מפתיע לגלות שמצבים שונים של האם שמאופיינים על ידי שינויים הורמונאליים, ישפיעו על אספקת החלב.
- הריון בזמן הנקה מבוססת או שאריות שליה עלולים להפחית את אספקת החלב.
- תופעות כמו סינדרום שחלות פובליציסטיות וציסטה מסוג מסוגים שונים, מחשדות בהשפעתן על דיכוי ההנקה.



אלכוהול

- שתיית אלכוהול פוגעת בהוצאת החלב.
- בניסוי שנערך על מנת לבחון את השפעת ריחו וטעמו של האלכוהול על חלב אם, נמצא כי תינוקות ינקו כמויות קטנות יותר של חלב לאחר שאמן שתתה משקה אלכוהולי.



תת פעילות של בלוטת יותרת המוח, או תסמונת שיהאן

- לאחר הלידה, היא תופעה נדירה. היסטוריה קודמת של דימום אחרי לידה עם לחץ דם נמוך משמעותית גורמים לסתימה תרומבוטית של החלק הקדמי של בלוטת יותרת המוח, ואיבוד של הורמונים אלו. במקרה כזה, אין הפרשת פרולקטין ולכן ההנקה נפסקת



בלוטות התריס

- יותר מ-5% מהנשים אחרי לידה סובלות מהפרעות בתפקוד של בלוטת התריס. זה יכול להופיע כתת פעילות או כפעילות יתר. הפרעות אלו יכולות לפגוע באספקת החלב.



התפתחות לא מספקת של הבלוטות

- כ-1 מתוך 1000 (0.01%) מהאמהות המניקות סובלות מסינדרום זה. הוא יכול להתבטא בחוסר סימטריה קיצונית בין השדיים, מעט או חוסר בשינויים בשדיים במהלך ההיריון, ואי יכולת לספק לתינוק את כמות החלב שהוא צריך.



ניתוחי שדיים

- ניתוחי שדיים כגורם עיקרי להפחתה ביצירת החלב. נשים שעברו התערבויות מסביב לאזור העטרה, צפויות לפתח פי 5 יותר בעיות באספקת החלב. כיום, שתלי סיליקון אינם מהווים מכשול לתהליך ההנקה.
- פרט חשוב נוסף בנוגע לנשים שעברו ניתוחי שדיים הוא להתעניין לגבי הפרטים שקדמו לניתוח: מידת החזה, צורתו, סימטריה והתפתחות השדיים לפני ההתערבות. רקמות שד לא מפותחות יכולות להיות הסיבה שהובילה לביצוע ההקטנה.



תזונת האם

- לא נמצא קשר חזק בין תזונת האם לכמות החלב שהיא מייצרת. תזונה דלה של האם תוביל למשקל לידה נמוך אצל העובר, וידוע כי תינוקות קטנים מעודדים יצירת כמות קטנה של חלב.
- אצל אישה שתזונתה מספקת, ירידה מהירה מאוד במשקל מחייבת בדיקה על השפעתה על נפח החלב.



גורמים פסיכולוגיים

- יש נשים שלא רוצות להניק אבל עושות זאת כתוצאה מלחץ משפחתי. תחת נסיבות אלו, פעמים נדירות ההנקה מצליחה.
- מקרים של התעללות בילד יונק פחות שכיחים, אבל קיימים. במיוחד אצל הורים שמכורים לאלכוהול או לסמים.
- התעללות מינית ביולדת
- אנורקסיה \ בולמיה קיום של הפרעות אכילה אצל האם



טיפול קליני קביעת הצורך בתוספות

- הרבה מקרים של עליה מעטה במשקל דורשים קבלת החלטה לגבי מתן תוספות. שני היבטים צריכים להילקח בחשבון:
- סוג התוספת
- דרך מתן התוספת.



גורמי האם: מחלה ברורה

- מחלות אקוטיות יכולות לגרום באופן זמני לירידה באספקת החלב, אך המצב אמור לחזור לקדמותו, במיוחד בהנקה מלאה.
- מסטיטיס יכולה להפחית את כמות החלב בשד הנפגע למשך ההנקה.
- יכולתן של נשים הסובלות ממחלות אחרות לייצר חלב תלויה במצבן הכללי.



מתי להחיל תוספות?

- ברוב המקרים, תוספת צריכה להתחיל ברגע שאתה יודע בודאות שהתינוק שלך לא מקבל מספיק חלב,
- כאשר תינוק מקבל מספיק אוכל, הוא יהיה מסוגל לינוק יותר טוב.
- למרות שתוספים יכולים להיראות כמו צעד מהנקה, נסו להראות לאימא שזה צעד שתומך בהנקה, כי זה סופו של דבר על מנת לעזור לתינוק לינוק יותר טוב.
- מכיוון שכל מקרה הוא ייחודי, חשוב לדון באסטרטגיות תוספים על מנת להבטיח שהתכנית תעבוד גם האם וגם בשביל התינוק.



יש היררכיה בנוגע לעדיפות התוספת:

- קודם כל חלב אם שאוב,
- אחרי זה חלב אם מתרומות
- והאופציה האחרונה היא מתן תמ"ל.
- השיטה המומלצת ביותר היא צינורית על השד. אופציות אחרות הן כוסית, מזרק, כפית ובקבוק. הבחירה תלויה בנסיבות.



כמה תוספת לתת?

- אין דרך ברורה לקביעת הסכום הכולל של חלב לה התינוק זקוק בכל יום.
- חלב אם נמדד בכמות ממוצעת של 120 CC למנה
- תרכובות חלב מחושבים על פי נוסחה
- X150 משקל התינוק
- מספר האכלות
- אצל פגים מחשבי את הקבוע ב 165



התערבות

- להגביר את תדירות, משך ויעילות ההאכלות על השד.
- ביצוע עיסויים לסירוגין והחלפת צדדים יכולים לעזור אם התינוק יונק באופן אקטיבי.
- לשאוב בין הנקות על מנת להגביר את כמויות החלב.
- אם התינוק יציב מבחינה קלינית ומראה סימני רעב, אפשר להציע לתת לו חלב שאוב כתוספת. אם הוא חייב לקבל תוספת, יש להשתמש בחלב אם שאוב (או אלטרנטיבה אחרת) כתוספת בזמן או לאחר ההנקות.
- יש להתחיל עם מינימום של cc30
- יש להגדיל את כמות התוספת לפי תיאבון התינוק.



החלפת צדדים SWITCH NURSING

- בהנקה "נורמלית" התינוק צריך לרוקן צד אחד לפני שהוא מעביר אותו לצד השני.
- אצל תינוק שמעביר חלק גדול מהזמן בהנקה nonnutritive ואינו עולה במשקל כמצופה, יש לשקול את שיטת החלפת הצדדים. האם אמורה להיות ערנית למעבר התינוק מיניקת nutritive ל-nonnutritive ואז להחליף צדדים כמה פעמים שצריך.
- שיטה זו אינה מתאימה לתינוקות שהם חלשים עקב לידה מוקדמת, מחלה או מאיבוד משקל, או לתינוקות בעלי הפרעה אוראלית - מוטורית עם יניקה חלשה.



פעולות המעודדות ייצור חלב

- הנחת קומפרסים חמים על השד מס' דקות לפני ההנקה
- עיסוי השדיים לפני ותוך כדי ההנקה או השאיבה
- טכניקות הרפיה להפחתת מתח ולעידוד הגעת החלב
- האכלת התינוק או ריקון החלב לפחות 8 פעמים בכל 24 שעות
- ריקון חלב לעיתים תכופות, גם אם מתקבלות כמויות קטנות בלבד.



GALACTAGOGUES

- הם גורמים שמזרחים או מגדלים את הפרשת החלב. מדובר בתרופות, עשבי מרפא או מאכלים.
- מטוקולופראמיד(פרמין) ניתן רק לאחר שנוסו אמצעים אחרים. המינון המקובל הוא 3 mg 10 פעמים ביום למשך 7 עד 14 ימים. כמויות קטנות של התרופה נכנסות לחלב, אך לא נמצאו תופעות לוואי אצל התינוקות. התופעות לוואי לאם כוללות סחרחורות, בחילות, זיעה ודיכאון. במקרה של דיכאון, יש להפסיק מייד את התרופה והסימפטומים נעלמים בערך בתוך שבוע.
- דומפרידון (מוטיליום) - השם המסחרי בישראל בשימוש במדינות אחרות (לא בארה"ב). הוא דומה למטוקולופראמיד, אך היתרון הוא שאין לו תופעות לוואי. תרבויות רבות משתמשות במאכלים וצמחים מסוימים כ-Galactagogues, כמו למשל השימוש בחילבה.



שקילת מבחן

- שקילת מבחן דורשת משקל אלקטרוני דיגיטלי מדויק עד רמת 2 ג' או פחות, המתחשב בתנועתיות של התינוק בזמן השקילה. התינוק נשקל לפני ואחרי ההנקה על מנת לקבוע את כמות החלב שצרך. הצריכה ב ml היא כמעט זהה לעליה במשקל בגרם.
- משקל רגיל אינו מתאים לשקילות מבחן.
- שקילת מבחן, במצבים מורכבים בהם התינוק אינו עולה במשקל ויש חשש להתפתחותו, מתבצעת בכל האכלה על מנת לקבוע את הצורך בתוספות.



הפחתת כמות התוספות

- ככל שאספקת החלב של האם תגדל, יש להפחית את כמות התוספות האחרות (כגון תמ"ל), לטובת חלב אם שאוב.
- ברגע שלאמא יהיה יותר חלב, התינוק ייקח כמות יותר גדולה ישירות מהשד ופחות תוספות.
- כאשר התינוק יגיע למשקל המתאים לגילו, כמות התוספות אמורה לרדת בהדרגתיות על מנת "לעודד" יצירת כמויות גדולות יותר של חלב אם. הדבר תלוי בתדירות ההנקות ויעילות חליבת התינוק.
- יש להמשיך לעקוב אחרי משקל התינוק במקביל להפחתת התוספות.



חלב אחורי

- חלב "אחורי" (hindmilk) הכוונה לחלב שמתקבל לקראת סוף ההנקה, בניגוד לחלב הראשוני, או "קדמי" (foremilk).
- מתן חלב "אחורי" לתינוק הינה שיטה אחת להגביר את התצרוכת הקלורית.
- יש להדריך את האמא להקפיא בכלים נפרדים חלב "קדמי" ו"אחורי", להאכיל את התינוק בחלב "אחורי", ולשמור את החלב הקדמי לתקופה אחרת.



אם התינוק אינו עולה במשקל כמצופה:

- לוודא שהתינוק מקבל את כמות התוספות המתאימה.
- לבדוק אם התינוק מוכן לקבל את הכמות המינימלית של תוספות. אם לא, יש לחשוף לקיומה של מחלה אורגנית או בעיה נזירולוגית.
- אם התינוק כן צורך את כמות התוספות שניתנה לו, ועדיין אינו עולה במשקל, יש לחשוף שמדובר במחלה או בעיה נזירולוגית.
- להמליץ על בדיקת מעבדה.
- לטפל במחלת התינוק כמסובר.
- אם ההמלצות אינן אפקטיביות, יש לשקול שימוש בטכניקות מיוחדות.



אם האימא לא הגבירה את יצירת החלב כעבור שבוע

- לבדוק את תדירות השאיבות
- להעריך מחדש את גורמי הסיכון של האם.
- לשקול בדיקת מעבדה (בעיקר בלוטת התריס).
- אם קיימים גורמים הקשורים באם, יש לפעול לפי ההדרכה.
- יש לשקול שימוש ב-galactagogue (גורם שמזרז או מגדיל את הפרשת החלב)
- אם הערכת האם שלילית, יש לבדוק שוב את התינוק.



כמות התוספת לנתינה באמצעות צינורית האכלה

- באופן כללי, לצריכה נורמאלית כוללת, החישוב הוא 150-200 מ"ל/ק"ג/יום של חלב אם או תמ"ל.
- גם אם התינוק עולה לאט במשקל, רוב היונקים מקבלים כמות כלשהי של חלב מהשד, לכן אנו מוסיפים כמות המייצגת צריכה חלקית.
- אלא אם כן נבצע שקילת מבחן, לא נדע בדיוק כמה התינוק מקבל מהשד. הקו המנחה הוא להתחיל עם מינימום של 60 מ"ל/ק"ג/יום המחולקים ל-6-8 האכלות



צינורית האכלה

- התינוק מקבל תוספת בזמן שהוא יונק מהשד. שיטה זו גורמת לתינוק לקבל נפח נוסף של חלב, בזמן שהוא ממשיך בגירוי יצירת חלב אימו. שיטה זו מונעת העדפת בקבוק על פני השד. צינורית האכלה טובה לתינוקות קטנים שיש להם הרבה אנרגיה ויניקה טובה, אך לאימם אין מספיק חלב. האם צריכה לקבל הדרכה בנוגע לחיבור וניקיון הצינורית.

ישנן שתי דרכים להתמודד עם תינוק שנחנק או מקיא עקב עודף חלב או זרימה מהירה

- הורדת כמויות החלב
- בדיקת בעיות יניקה- בליעה- נשימה אצל התינוק.
- מחנק בזמן שחרור החלב או משיכה בשד בזמן האכלה יכול להצביע על קושי בשילוב היניקה- בליעה- נשימה.
- תינוק עם ריפלוקס אמיתי יכול להפגין תסמינים דומים.

יותר מדי חלב

- אם ייצור החלב גובר על דרישת התינוק או על היכולת להניק, ייצור יתר יכול להיות בעיה.
- אספקת החלב בדרך כלל מאזנת את עצמה סביב גיל ששה שבועות, במיוחד כאשר יש הנקה לפי דרישה. בשבועות הראשונים לאחר הלידה נוצר "רף עליון" של יצור חלב אפשרי לאותה תקופת הנקה. לאחר שנוצר רף זה, כמות החלב יכולה לפחות ולעלות חזרה לפי הצורך
- גם שיטת ההאכלה יכולה להשפיע על יצור יתר, כמו העברת התינוק מהצד הראשון לפני שהביע רצון לעבור לצד שני. יצור יתר יכול להיות מקושר לתחושה חזקה ברפלקס שחרור החלב.



סוף טוב הכול טוב

מה עושים ?

- הציעי רק שד אחד בכל הנקה. אם השד השני מלא וגורם לאי נוחות יש לרוקן עד להקלה בלבד ולשמור את החלב הקפוא לשימוש עתידי.
- נסי תנוחות שונות להנקה. לעיתים נוח לתינוק לינוק בצורה אנכית. השעני מעט אחורנית, כך שכח המשיכה יגרום לפחות חלב להגיע לפה התינוק. לעיתים גם שכבה על הצד מועילה.
- הרחיקי את התינוק כאשר מגיע רפלקס שחרור החלב ואפשרי לפרצי החלב להיספג במגבת, אח"כ חברי את התינוק מחדש.
- השתמשי בתרופות מדכאות חלב רק כמוצא אחרון.